

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

Nelson Raimundo de Souza

IDADE: 71 PESO: 94 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: comércio (Aviamentos)

SINTOMAS: MMIS demorado / Refluxo (viagem todos os dias)

QUEIXAS: Dorco / memórias ↓ p/s.p.

MEDICAMENTOS: Exomeprazol / Ritmonorm / Felozolque /

Diazepam / Novano / Rosuvastatina / Promaxa

MÉDICO: Dr. Carlos Eduardo

MARCAPASSO: () SIM (X) NÃO / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () SIM (X) NÃO

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 2 vezes LANCHE: fruta JANTAR: lanche (18h)

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 4:20

COCHILHO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO esposa nunca

FUMO (X) SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: as vezes

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 39

OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 50.7 SPO2: 84%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 1X apneia. (Dorme de lado; braços;)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim IMC: 34.53

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS DOR NO JOELHO

10/08 máscara D. Pileave + tubo + Água

04/09 P=8,5 cm H₂O IAH=1,9 e/h Bem adaptado.

24 m. de uso: 5h30' fim

18/10/24 P=8,8 cm H₂O IAH=1,9 e/h Oriento posicionamento de máscara p/ evitar vazamento
m. de uso: 4h58
pressão: 18,5 mmHg
notícia

Nome: NELSON RAIMUNDO DE SOUZA

Data de Nascimento: 30-3-1953

IMC: 34,53

Sexo: Masculino

Data do exame: 17-06-2024

Peso: 94 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. CARLOS EDUARDO FRANÇA

QUINTA FEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 17-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 583,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 190,5 e 211,5 minutos. O tempo total de sono foi de 138,5 min, eficiência de 23,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 5,4%; estágio N2: 68,6%; estágio N3: 10,5%; sono REM: 15,5%. O índice de despertares foi de 10,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 50,7/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 117 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 91% e a mínima de 84%, permanecendo 2,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 68 bpm e NREM de 59 - 71 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem dos estágios N1 e N2 do sono NREM aumentadas;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 50,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=84%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (25,6/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 0-14 hora leve

IAH: 15-30 hora moderada

IAH: > 30 hora acentuada

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Dr. José Mario Simões da Costa

Medicina do Sono

CRM 21.477